



Doel: Kennis ophalen over de angst voor algoritmes en AVG-risico's in de zorg. Dit geeft je munitie om te schrijven over hoe jij de AVG-risico's afdekt en teams meeneemt (o.a. met LEGO® Serious Play).

Systeemrol & Context: Je bent een specialist op het snijvlak van Legal Tech, de AVG en ethische AI-implementatie in de Nederlandse publieke sector en zorg.

Opdracht: Breng de reële risico's, wetgeving (zoals de AI Act) en de heersende angst/weerstand in kaart omtrent het gebruik van AI in het Nederlandse welzijnswerk en cliëntencontact.

Wat zijn de harde AVG-richtlijnen waar een welzijnsinstelling aan moet voldoen als ze AI-tools (zoals samenvatters van cliëntgesprekken) willen gebruiken? Wat mag absoluut wel en niet met cliëntgegevens?

Wat zijn de meest gehoorde ethische bezwaren van medewerkers in de zorg/welzijn tegenover algoritmen ("Mag een algoritme iets vinden van een cliënt?")?

Zoek naar succesvolle methodieken of frameworks (zoals actiegericht leren of visuele strategiesessies) die in de praktijk worden gebruikt om deze angst bij teams te doorbreken en draagvlak te creëren.

Output vereisten: Heldere scheiding tussen harde juridische feiten (AVG/AI Act) en psychologische/organisatorische weerbarstigheid op de werkvloer.

De kern: juridisch mag een welzijnsinstelling AI alleen inzetten rond cliëntcontact als je de AVG-basisprincipes strak organiseert (grondslag, dataminimalisatie, beveiliging, DPIA, afspraken met leveranciers) én voorkomt dat algoritmen zelfstandig bepalen wie welke voorziening krijgt of cliënten (impliciet) scoren. Tegelijk zit de meeste weerstand bij zorg- en welzijnsprofessionals niet in "de wet", maar in angst voor ontmenselijking, toezicht ("big brother") en herhaling van Toeslagen-achtige algoritmeschandalen; die angst vraagt om dialoog, co-creatie en ervaringsgerichte methoden zoals LEGO Serious Play in plaats van alleen compliance-slides. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#)

Juridische basis: AVG, UAVG, WGBO en AI Act

AI-gebruik in zorg en welzijn valt onder de AVG, de Uitvoeringswet AVG (UAVG), het medisch beroepsgeheim/WGBO en – als het om AI-systemen gaat – de EU AI Act. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[9\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#)

De AVG stelt dat gezondheidsgegevens en gegevens over sociale problematiek "bijzondere persoonsgegevens" zijn, waarvoor verwerking in principe verboden is tenzij een specifieke

uitzondering geldt (zoals noodzakelijkheid voor behandeling, kwaliteit van zorg of onderzoek).^{[10] [2] [3]}

De AI Act introduceert een risicobenadering: sommige AI-toepassingen worden verboden (o.a. manipulatieve systemen, sociale scoring), andere vallen in de categorie hoog risico, bijvoorbeeld wanneer AI meebeslist over essentiële diensten of zorgtoegang; lichtere toepassingen vallen onder transparantie-eisen.^{[11] [9] [1]}

Voor zorginstellingen geldt dat veel diagnostische en beslissingsondersteunende systemen als high-risk worden gezien, terwijl ondersteunende tools zoals transcriptie en samenvatting meestal in een lagere risicoklasse vallen zolang ze niet beslissend zijn voor toegang tot voorzieningen.^{[12] [2] [4] [11]}

AVG-basisprincipes bij AI in welzijnswerk

De AVG blijft leidend, óók als je een “hippe” AI-tool inzet.^{[2] [3]}

Belangrijke principes zijn: doelbinding (alleen gebruiken voor een duidelijk omschreven doel, zoals dossiervorming of kwaliteitsverbetering), minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking en integriteit en vertrouwelijkheid.^{[3] [4]}

Omdat je met cliënten over gezondheid, schulden, veiligheid, gezinssituatie of justitiële issues spreekt, verwerk je structureel bijzondere persoonsgegevens; daarvoor heb je een specifieke grondslag nodig (bijvoorbeeld noodzakelijkheid voor goede behandeling/ondersteuning of een wettelijke taak in het sociaal domein) en moet je extra waarborgen treffen.^{[4] [10] [3]}

De AVG-helppdesk voor Zorg en Welzijn benadrukt dat AI grote kansen biedt, maar dat het risico bestaat dat er “te veel data” wordt verzameld of dat een algoritme bestaande maatschappelijke bias versterkt.^[2]

Specifiek: opnemen, transcriberen en samenvatten van cliëntgesprekken

In welzijnswerk en Wmo-/jeugdteams gaat jouw concrete use-case vaak over: gespreksopnames, AI-transcriptie en samenvatten voor verslaglegging.^{[13] [14] [15]}

Wat moet minimaal geregeld zijn?

- **Rechtsgrond en doel:** opnemen en transcriberen moet noodzakelijk zijn voor goede dossiervorming/continuïteit van zorg óf expliciet met geïnformeerde toestemming van de cliënt gebeuren.^{[14] [3] [4]}
- **Informatieplicht:** cliënten (en eventueel naasten) moeten vooraf weten dat er wordt opgenomen, waarom, hoe lang bewaard wordt en wie toegang heeft.^{[13] [14]}
- **Dataminimalisatie:** neem niet méér op dan nodig (geen ‘permanent meeluisteren’), en zorg dat de opname zo snel mogelijk wordt omgezet in een transcript en daarna – als het doel dat toelaat – wordt verwijderd.^{[14] [13]}
- **Beveiliging en locatie:** gebruik bij voorkeur transcriptiesoftware die in de EU draait, met passende beveiliging en zonder dat de leverancier de data zelf mag hergebruiken;

publieke generatieve AI-diensten buiten de EU zijn in de zorg al tot datalekken gaan leiden.^{[16] [2] [14]}

- **Verwerkersovereenkomst:** met elke AI-leverancier is een verwerkersovereenkomst nodig waarin staat wat er met de data gebeurt, hoe lang, waar de servers staan en dat er geen eigen trainingsgebruik plaatsvindt zonder aparte grondslag.^{[17] [3] [4]}
- **DPIA:** vanwege de combinatie van kwetsbare groepen en nieuwe technologie is een Data Protection Impact Assessment (DPIA) feitelijk verplicht voordat je AI voor cliëntgesprekken uitrolt.^{[18] [4]}

Zowel DigiTip “veilig transcriberen in de zorg” als partijen zoals Voys en Mextra waarschuwen expliciet tegen het gebruik van generieke transcriptie-/AI-diensten voor “zeer gevoelige persoonsgegevens”, juist omdat je snel buiten de AVG-bandbreedte belandt.^{[19] [16] [13] [14]}

Wat mag beslist niet met cliëntgegevens?

Op basis van AVG, UAVG, beroepsgeheim en AI-/discriminatie rapporten kun je voor jouw doelgroep best scherp formuleren wat níet kan.^{[8] [20] [3] [2]}

Absoluut niet of alleen onder zeer strikte voorwaarden:

- **Cliëntgegevens invoeren in publieke AI-tools (zoals open chatbots) zonder verwerkersovereenkomst en EU-datalocatie.** De AP rapporteerde meerdere incidenten in 2024 waarbij zorgmedewerkers vertrouwelijke patiëntgegevens in publieke AI invoerden; dat werd als datalek gezien.^{[16] [2]}
- **Gebruik van gezondheids- of sociale data voor commerciële of secundaire doelen (marketing, productontwikkeling) zonder aparte grondslag en duidelijke toestemming.**^{[10] [3] [17]}
- **Sociale scoring en risicoprofielen op basis van nationaliteit, etniciteit of sociaaleconomische status.** Toeslagen-onderzoek laat zien dat dergelijke algoritmen tot verboden discriminatie leiden.^{[20] [21] [8]}
- **Emotie-/stressherkenning uit video/spraak van cliënten om gedrag te sturen of voorzieningen te beperken.** De AI Act plaatst emotie-analyse en gezichtsclassificatie in Annex III als risicodomein; in sommige contexten (zoals onderwijs en werk) is dergelijke AI (nagenoeg) verboden of high-risk.^{[9] [22] [1]}
- **Volledig geautomatiseerde beslissingen over toegang tot voorzieningen, zonder “meaningful human oversight”.** Zowel AVG (art. 22) als AI Act benadrukken dat mensenrecht-gevoelige beslissingen niet aan black-box algoritmen mogen worden overgelaten.^{[22] [1] [4]}

Dit is precies het beeld dat maatschappelijke organisaties en toezichthouders schetsen als ze waarschuwen voor institutionele discriminatie door algoritmen bij de overheid.^{[23] [24] [22] [8]}

Wat mag in principe wél met cliëntgegevens (mits goed ingericht)?

Er zijn ook duidelijke “groene zones” waarin AI professioneel mag ondersteunen, zolang je de AVG-principes en AI-richtlijnen volgt.^{[25] [26] [3] [2]}

- AI-gestuurde transcriptie en samenvatting van gesprekken, mits:
 - het dient voor dossiervorming, continuïteit of kwaliteitsverbetering van zorg/welzijn,
 - er een passende grondslag is (zorgverlening, publieke taak, of expliciete toestemming),
 - het in een beveiligde, Europese omgeving gebeurt,
 - en mensen (professionals) de uitkomst controleren en corrigeren.^{[15] [13] [2] [14]}
- Beslisondersteuning (bijvoorbeeld suggesties voor vervolgstappen in begeleiding) zolang de professional eindverantwoordelijk blijft, het systeem uitlegbaar is en de cliënt desgewenst kan horen hoe AI een rol heeft gespeeld.^{[27] [4] [25] [2]}
- Geanonimiseerde of goed gepseudonimiseerde data-analyse voor beleids- en impactrapportages, mits je zorgvuldig voorkomt dat individuele cliënten alsnog te herleiden zijn.^{[26] [3] [4]}

Leidraden als “Leidraad kwaliteit AI in de zorg” en de actuele onderzoeken van VWS/Data voor Gezondheid benadrukken dat de inzet van AI voor administratieve verlichting en kwaliteitsverbetering juist wenselijk is, zolang transparantie, validiteit, bias-beheersing en menselijke controle aantoonbaar geregeld zijn.^{[28] [4] [25] [26]}

AI Act: wanneer wordt welzijns-AI hoog-risico?

De AI Act maakt een onderscheid tussen verboden, hoog-risico en beperkte-risico-systemen.^{[11] [1] [9]}

In het sociaal domein wordt AI hoog-risico zodra het systeem:

- Meebeslist over toegang tot essentiële diensten zoals uitkeringen, schuldhulp, zorgvoorzieningen of huisvesting (Annex III “essentiële publieke en private diensten”).^[1]^{[8] [20]}
- Gebruikt wordt voor risicoprofilering van burgers door of namens de overheid (denk aan fraude-detectie of risicoscores voor “zorgmijders”).^{[8] [23] [1]}
- Ingrijpt in het arbeidsdomein (bijvoorbeeld matching van cliënten naar werktrajecten) of onderwijs (toeleiding van jongeren naar voorzieningen).^{[22] [1]}

Dan gelden zwaardere eisen: risicomanagementsysteem, datakwaliteitseisen, technische documentatie, logging, transparantie, menselijke supervisie en robuuste monitoring.^{[9] [4] [1]} Voor jouw scenario van AI-samenvatters in cliëntcontact zit je eerder in de categorie “limited risk”, mits de tool puur ondersteunend is en niet zelfstandig bepaalt of iemand wel/niet in aanmerking komt voor een voorziening.^{[12] [15] [11] [2]}

Ethische bezwaren en angst bij medewerkers

De psychologische weerstand is in de praktijk minstens zo groot als de juridische drempels.
[29] [5] [6] [30] [27]

Uit onderzoeken onder zorgprofessionals blijkt dat zij AI vooral vertrouwen voor administratieve taken (zoals verslaglegging en monitoring), maar beduidend minder voor diagnostiek of voorspellende modellen; tegelijk vindt ruim een derde dat innovatie wordt tegengehouden door angst en risicomijding. [5] [27] [15]

In bredere Future-of-Work- en AI-onderzoeken geeft rond tweederde van de professionals aan dat AI zonder duidelijke ethische kaders meer risico's dan voordelen oplevert, en dat digitale stress en weerstand tegen verandering in de zorg hoger liggen dan in andere sectoren. [31] [6] [30]

Typische bezwaren en vragen die jij in teams zult horen:

- “Mag een algoritme iets vinden van een cliënt?”
Achter deze vraag zit angst voor nieuwe vormen van stigmatisering en “digitale etiketten”, gevoed door voorbeelden als de Toeslagenaffaire waarin algoritmen discriminerende risicoprofielen maakten. [32] [20] [8]
- Vrees voor dehumanisering: professionals zijn bang dat contact instrumenteel wordt (“de computer zegt dat dit een hoog risico-gezin is”) en dat hun relationele expertise minder telt. [33] [34] [27]
- Onzekerheid over verantwoordelijkheid: wie is aansprakelijk als een AI-samenvatting iets mist, of als een risicoscore later onterecht blijkt? [33] [25] [10] [2]
- Wantrouwen door gebrek aan transparantie: algoritmen worden ervaren als “black box” – men weet niet welke data erin gaan en welke aannames zijn ingebouwd. [4] [23] [22]
- Angst voor baanverlies en extra werkdruk: zorgmedewerkers geloven wel dat AI administratie kan verlichten, maar zijn bang dat de vrijgekomen ruimte vooral wordt gebruikt om méér cliënten te zien in plaats van rust te creëren. [6] [5] [15]
- Digitale onzekerheid: een groot deel van de zorg- en welzijnsprofessionals voelt zich ontervoorbereid op nieuwe technologie, ervaart digitale stress en vreest afgerekend te worden op fouten in digitale systemen. [31] [27] [6]

Ethiekplatforms in de zorg benadrukken dat goede AI-implementatie daarom altijd gepaard moet gaan met expliciete waarden-dialogen: wat vinden wij goede zorg, welke waarden (autonomie, rechtvaardigheid, menselijkheid) willen we borgen, en hoe helpt of schaadt AI daarbij? [34] [28] [33] [10]

Juridische feiten vs. psychologische weerbarstigheid (kort kader)

Je kunt in jouw communicatie expliciet twee “lagen” benoemen:

- Harde laag – juridische en technische randvoorwaarden
 - AVG-principes, grondslag, DPIA, verwerkersovereenkomsten, beveiliging, data-locatie, logging. [3] [25] [2] [4]

- AI Act-indeling (verboden, hoog-risico, beperkt risico) plus sectorale leidraden zoals de Leidraad kwaliteit AI in de zorg.^{[25] [26] [11] [1]}
- Zachte laag – beleving, vertrouwen en ethiek in teams
 - Angst voor controle, fouten, discriminatie en ontmenselijking.^{[5] [6] [20] [8]}
 - Digitale vaardigheden, werkdruk en veranderbaarheid.^{[27] [6] [31]}

Dat onderscheid geeft je “munitie” om tegelijk gerust te stellen (“zo dekken we risico’s af”) en serieus te nemen wat medewerkers voelen (“en zo gaan we met jullie zorgen aan de slag”).^{[28] [17] [16]}

Praktische “mag wel / mag niet” voor AI-samenvatters

Je kunt richting bestuur en teams een concreet kader formuleren, bijvoorbeeld:

Mag wél (onder voorwaarden):

- Gesprekken met cliënten opnemen, transcriberen en laten samenvatten in een beveiligde, Europese AI-omgeving die aantoonbaar AVG-conform is, uitsluitend ten behoeve van dossiervorming, continuïteit en kwaliteitsverbetering.^{[13] [2] [4] [14]}
- AI-samenvatting gebruiken als kladversie die de professional altijd controleert, corrigeert en in eigen woorden in het dossier zet; de professional blijft inhoudelijk eigenaar.^{[15] [27] [25]}
- Anoniem of sterk gepseudonimiseerd gebruik van gespreksdata om patronen te zien (bijvoorbeeld welke vragen vaak blijven liggen), mits herleidbaarheid tot individuen praktisch is uitgesloten.^{[26] [3] [4]}

Mag niet / liever niet:

- Cliëntnamen, BSN, diagnoses en casuïstiek invoeren in generieke AI-chatbots of transcriptietools zonder duidelijke verwerkersovereenkomst en EU-hosting.^{[19] [16] [2] [3]}
- Samenvattingen of risicoscores direct gebruiken om toegang tot activiteiten, begeleiding of voorzieningen te beperken, zonder menselijke herbeoordeling.^{[1] [4] [22]}
- Algoritmen trainen of laten trainen op ruwe cliëntdata voor andere doelen (bijv. productontwikkeling van de leverancier) zonder afzonderlijke grondslag, ethische afweging en – vrijwel altijd – expliciete toestemming en anonimisatie.^{[28] [17] [10] [3]}

Dit soort checklists sluit aan bij aanbevelingen van privacy- en AI-helpdesks voor de zorg, die benadrukken dat “algoritmen ondersteunen” in plaats van “overnemen” het uitgangspunt moet zijn.^{[2] [28] [4] [25]}

Methodieken om angst te doorbreken en draagvlak te bouwen

Onderzoek naar digitale transformatie in de zorg laat zien dat je professionals vooral meekrijgt met co-creatie, ervaringsgericht leren en concrete praktijkcases – niet met dikke beleidsnotities alleen.^{[29] [6] [31] [27] [26]}

1. Actiegericht leren en kleine experimenten

- Werk met **pilots** in één team of locatie, met duidelijke leerdoelen: bijvoorbeeld “kan AI ons 30% tijd schelen op rapportages zonder dat kwaliteit daalt?”.^{[27] [15]}
- Combineer training over AVG/AI Act met live-demonstraties van transcriptie/samenvatting, zodat angst voor het onbekende afneemt en mensen zelf fouten en verbeterpunten zien.^{[18] [26] [13] [2]}
- Laat teams zelf criteria formuleren: wat vinden wij goede AI-ondersteuning, en wanneer moeten we ermee stoppen? Dit sluit aan bij de kwaliteits- en ethiekleidraden.^{[33] [28] [25]}

2. Co-creatie en ethische dialoog

- Organiseer **ethiekssessies** of **moreel beraad** specifiek over AI: casussen bespreken, waarden expliciteren (autonomie, rechtvaardigheid, menselijkheid) en samen grenzen trekken (“dit willen we nooit, dit misschien wel”).^{[34] [10] [28] [33]}
- Gebruik **scenario-onderzoek** en voorbeelden (zoals Toeslagen) om te laten zien wat er mis kán gaan, maar ook positieve cases waarin AI juist administratieve druk verlicht zonder cliënten te schaden.^{[35] [20] [15] [8]}

3. Visuele en ervaringsgerichte strategiesessies (incl. LEGO Serious Play)

Methodieken als LEGO Serious Play worden in zorg- en onderwijscontext al gebruikt voor strategievorming, samenwerking en verandertrajecten.^{[36] [37] [7] [38] [39]}

Kenmerkende elementen:

- **Denken met je handen:** deelnemers bouwen hun beeld van “AI in onze organisatie”, inclusief muren (weerstand), bruggen (kansen) en risico’s; dit maakt impliciete emoties en overtuigingen zichtbaar.^{[7] [38] [39] [36]}
- **100% participatie:** geen dominante praters; iedere professional bouwt en vertelt, wat belangrijk is bij thema’s als angst, schaamte en digitale onzekerheid.^{[37] [39] [7]}
- **Van individuele modellen naar een gezamenlijk model:** teams bouwen letterlijk aan een gedeelde visie en routekaart (“van huidige situatie naar gewenste AI-ondersteunde werkwijze”), inclusief concrete interventies en safeguards.^{[38] [37] [7]}

Case-beschrijvingen laten zien dat LSP-sessies bij digitalisering in zorginstellingen helpen om weerstand te herkennen (modellen met muren) én energie te vinden (modellen met bruggen, extra tijd voor cliënten).^{[37] [7]}

Dat sluit direct aan bij jouw profiel als facilitator op het snijvlak van AI, ethiek en LEGO Serious Play: je kunt juridische randvoorwaarden “verbeelden” in metaforen (hekwerk rond gevoelige data, menselijke poortwachters voor beslissingen) en zo compliance koppelen aan beleving.^{[39] [7] [38]}

4. Digitale vaardigheid en steunstructuren

Onderzoek naar digitale vaardigheden in de zorg toont dat ongeveer de helft van de professionals zich onder het gewenste niveau bevindt; werkdruk, gebrek aan tijd en angst om fouten te maken zijn grote barrières.^{[6] [31] [27]}

Werkzame elementen:

- **Micro-leersprints:** korte, herhaalbare oefeningen (bijv. “in 15 minuten een gespreksverslag laten samenvatten en controleren”).^{[31] [27]}
- **Buddy-systemen:** digitaal vaardigere collega's koppelen aan minder vaardige, zodat AI niet “iets van ICT” blijft maar onderdeel van het team.^{[6] [31]}
- **Geen afrekencultuur:** expliciet maken dat fouten in pilots leermateriaal zijn, niet iets waarvoor je op het matje wordt geroepen.^{[34] [33] [6]}

Hoe jij dit kunt framen in jouw verhalen

Met deze inzichten kun jij, als AI-wellbeing/innovatie-partner, heel concreet schrijven en spreken over:

- “Zo dekken we AVG- en AI-Act-risico's af” – met duidelijke do's/don'ts rond AI-samenvatters en cliëntdata, gebaseerd op AVG-helpdesk, AP-incidenten en sectorleidraden.^{[16] [3] [4] [25] [2]}
- “Zo nemen we teams mee” – met LEGO Serious Play, co-creatie en actiegericht leren als antwoord op angst voor algoritmes, digitale onzekerheid en ethische zorgen.^{[36] [7] [38] [37] [31] [6]}

Die combinatie – harde juridische kaders én zachte veranderaanpak – is precies waar veel Nederlandse welzijnsorganisaties nu naar zoeken.^{[17] [29] [28] [16]}

✱

1. <https://www.aiactblog.nl/nl/posts/hoog-risico-ai-systemen>
2. <https://www.avghelpdeskzorg.nl/onderwerpen/k/kunstmatige-intelligentie>
3. <https://privacy-web.nl/artikelen/ai-in-de-zorg-privacy/>
4. <https://www.datavoorgezondheid.nl/onderwerpen/a/ai-in-de-zorg/parlementair-beleid-en-juridische-kaders/juridische-kaders>
5. <https://www.skipt.nl/nieuws/zorgprofessionals-ai-wordt-overschat-als-oplossing-voor-personeelstekort/>
6. <https://www.icthealth.nl/nieuws/zorg-ziet-ai-en-voldoende-personeel-als-grootste-uitdagingen>
7. <https://lspacademy.nl/management-lego-serious-play/>
8. <https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/tech-en-mensenrechten/algoritmes-big-data-overheid>
9. <https://didev.nl/ai/eu-ai-act-complete-gids-voor-nederlandse-organisaties-2025/>
10. <https://lawandmore.nl/nieuws/data-ethiek-in-de-zorg-de-juridische-grenzen-van-het-delen-van-patiëntgegevens/>

11. <https://hanzeadvocaat.nl/nieuws/ai-act-in-de-zorg-geen-toekomstmuziek-maar-realiteit/>
12. <https://www.ictrecht.nl/blog/ai-act-in-de-zorg-praktische-toepassing>
13. <https://www.digivaardigindezorg.nl/digitip-veilig-en-makkelijk-transcriberen-in-de-zorg-met-ai/>
14. <https://www.voys.nl/blog/ai-transcriptie-klantgesprekken-automatisch-verwerken-met-respect-voor-privacy/>
15. <https://www.tno.nl/nl/newsroom/insights/2024/12/ai-druk-zorg-verminderen/>
16. <https://www.dutchitleaders.nl/news/668664/vier-aanbevelingen-voor-verantwoord-ai-gebruik-in-de-zorg>
17. <https://www.inquire.health.nl/blog/zorgdragen-voor-vertrouwen-in-ai-gdpr-ethiek-en-veilige-ai-in-de-europese-gezondheidszorg>
18. <https://www.datavoorgezondheid.nl/site/binaries/site-content/collections/documents/2025/01/06/rapport-leidraad-kwaliteit-ai-in-de-zorg/rapport-leidraad-kwaliteit-ai-in-de-zorg.pdf>
19. <https://mextra.nl/nieuws/chatgpt-in-de-zorg-risico-en-kansen/>
20. <https://herstel.toeslagen.nl/gebruik-van-dubbele-nationaliteit/>
21. <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-708.html>
22. <https://governance-web.nl/nieuws/toezicht-op-discriminatie-door-algoritmes-en-ai-systemen-moet-beter/>
23. <https://privacy-web.nl/publicaties/rapport-toezicht-op-het-gebruik-van-algoritmen-door-de-overheid/>
24. https://www.eerstekamer.nl/bijlage/20250203/position_paper_autoriteit/document3/f=/vml1m6wup0h2.pdf
25. <https://www.lumc.nl/actueel/2021/leidraad-kwaliteit-ai-in-de-zorg/>
26. <https://www.datavoorgezondheid.nl/actueel/nieuws/2025/09/08/leidraad-kwaliteit-ai-in-de-zorg-nader-onderzocht>
27. <https://www.ilionx.com/blogs/ai-in-de-zorg-potentie-voor-efficientie-en-kwaliteitsverbetering/>
28. https://www.sigra.nl/uploads/2024-10/Sigra P&I 2024 - Ethische richtsnoeren betrouwbare AI_0.pdf
29. <https://www.perplexity.ai/search/639eeb2f-47bb-4cf2-87a2-a7402906e983>
30. <https://www.philips.nl/a-w/about/news/future-health-index/reports/2025/building-trust-in-healthcare-ai.html>
31. <https://www.perplexity.ai/search/ed97fdd9-6b7f-4392-9fd9-2568d4663c4f>
32. <https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2025D04274>
33. <https://www.icthealth.nl/ethiek>
34. <https://www.zorgvoorbeter.nl/thema-s/zingeving/ethiek-in-de-zorg>
35. <https://www.perplexity.ai/search/6889138e-cf4e-419b-924d-6548a2caefb0>
36. <https://www.gemeenschapsontwikkeling.nl/diensten/co-creatie-met-lego-serious-play>
37. <https://www.han.nl/over-de-han/organisatie/bedrijfsonderdelen/han-seneca/aanbod/lego-serious-play/>
38. <https://www.mvc.nl/lego>
39. <https://www.businesspartneronline.nl/diensten>
40. https://www.reddit.com/r/werkzaken/comments/1nakx8c/ongevraagd_een_gesprek_opnemen/
41. <https://pure.uva.nl/ws/files/152005017/Toekomst-van-zorg-en-algoritmen-SCENARIOS-def.pdf>

42. <https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D56237>
43. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/426533/Selectie_aan_de_grens_over_etnische_profilerings_algoritmes_en_het_recht_op_non_discriminatie.pdf?sequence=1
44. https://www.sigra.nl/uploads/2024-10/Leidraad_kwaliteit_AI_in_de_zorg_NL.pdf